Processo nº **0042238-60.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): ISABEL CRISTINA FERREIRA

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA – *Extinção com resolução do mérito*

Vistos etc.

ISABEL CRISTINA FERREIRA, brasileira, divorciada, aposentada, portadora da carteira de identidade nº. 1.494.885, inscrita no CPF/MF sob o nº. 279.824.404-87, residente e domiciliada à Rua Jornalista José Campelo Junior, n. 662, Agua Fria, Recife-PE, CEP 52120-175, por intermédio de advogados regularmente constituídos, ingressou com a presente "AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTEAL – INAUDITA ALTERA PARS – nos termos do Art. 294, 295 §1º, 300, 318, 319, 497 e seguintes todos do NCPC" em face da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 63.554.067/0001-98, empresa com sede na Rua Pacífico dos Santos, nº 25, Paissandu, Recife/PE, CEP 52010-03 alegando, em síntese, que foi diagnosticada com doença grave (Fibrose Pulmonar Idiopática – CID 10J84-1) e diante desse diagnóstico, seu médico

assistente (Dr. Manoel Vieira Salgado Filho – CRM-PE 4578) prescreveu a substância NINTEDANIBE 150MG, cujo nome comercial é OFEV 150mg, a ser administrado 1 comprimido de 12 em 12 horas de forma contínua.

Informa que foi requerida autorização para que o plano de Saúde Réu autorizasse o custeio com o medicamento, o qual fora indeferido sob o argumento de que "medicamento estava sendo prescrito de forma OFFLABEL, fora do DUT".

Requereu fosse deferida a tutela de urgência a fim de compelir o Requerido a custear o medicamento com prescrito, e no mérito a confirmação da tutela e a condenação em danos morais.

Instruiu a Exordial com os documentos de ID's n. 167841072 a 167842798.

Decisão interlocutória a qual concedeu a tutela de urgência (ID 168115456).

Instada a se contrapor aos substratos fático e jurídico delineados na peça de ingresso, a demandada deduziu a contestação de ID n. 170316775.

Réplica (ID n. 176322969).

As partes foram intimadas acerca da produção de novas provas, tendo ambas se manifestado pugnando pelo julgamento antecipado.

Em seguida, os autos me vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

Inicialmente, pontue-se que a demanda em tela comporta julgamento antecipado (*julgamento conforme o estado do processo*), posto que, embora envolva matéria fática, entendo que não há necessidade de produção de provas outras além das que já foram produzidas (*art. 330, I, do Código de Processo Civil*).

Analisando o álbum processual, afere-se que a demandante submeteu ao crivo deste Juízo o presente feito com o fito de compelir o Plano de Saúde Requerido a fornecer determinada medicação, mais especificamente ***NINTEDANIBE 150MG, sendo 02 (dois) comprimidos diários (60 comprimidos mensais), por prazo indeterminado,*** por ter sido diagnosticada portadora de doença grave, qual seja, Fibrose Pulmonar Idiopática FPI (CID-J84.1).

Visando subsidiar os argumentos expendidos na peça atrial, trouxe à baila os elementos de ID's nº 167841072 a 167842798.

Consoante outrora asseverado, a demandada, devidamente citada para angularizar a relação processual, deduziu a contestação de ID n. 170316775.

No mérito, pugnou pela improcedência da demanda, sob o argumento de que o medicamento que a parte autora pleiteia segundo a diretriz de utilização – DUT disponível no anexo II da RN 465/2021 DA ANS, é indicado para terapia antineoplásica oral para tratamento de câncer.

Contudo, assevera que a comorbidade da parte autora (fibrose pulmonar) não se enquadra em qualquer das hipóteses contempladas na DUT que impõem o fornecimento do medicamento, e portanto não é de cobertura obrigatória.

Alegou, também que o medicamento é de uso domiciliar, isto é, que não necessita ser administrado em ambiente hospitalar ou de saúde e o contrato de seguro-saúde contratado exclui a cobertura para medicamentos de uso domiciliar, bem como os que não possuem previsão no rol da ANS.

Neste sentido, esclareceu que a única exceção à inadmissibilidade de disponibilização de medicamentos orais para tratamento domiciliar é em relação aos antineoplásicos orais (*e correlacionados*), à medicação assistida (*home care*) e os incluídos no rol da ANS para esse fim, situações estas em que não se incluem à presente demanda, razão pela qual a pretensão deduzida na inicial esbarra em óbices legal e contratual.

Estabelecidas essas premissas, sem questões preliminares passo ao enfrentamento do mérito da questão posta.

Pois bem, em sua inicial, a parte autora, como forma de subsidiar o direito que pleiteia, acostou aos autos um receituário médico (id. 167842789), e outros laudos de exames (id. 167842791; 167842792).

Nesse diapasão, insta consignar que o plano de saúde demandado, quando da contestação, no intuito de desconstituir o direito da autora, informou que, que o medicamento que a parte autora pleiteia segundo a diretriz de utilização – DUT, disponível no anexo II da RN 465/2021 DA ANS, é indicado para terapia antineoplásica oral para tratamento de câncer.

Contudo, assevera que a comorbidade da parte autora (fibrose pulmonar) não se enquadra e, nenhuma das hipóteses contempladas na DUT que impõem o fornecimento do medicamento, e, portanto, não é de cobertura obrigatória.

Continuou argumentando que o plano somente estaria obrigado a prestar medicação de uso domiciliar no caso dos antineoplásicos orais (*e correlacionados*), da medicação assistida (*home care*) e dos incluídos no rol da ANS para esse fim, conforme a legislação da matéria.

Em outras palavras, não sendo a medicação pleiteada pela parte autora administrada em ambiente hospitalar ou de saúde -*e não estando, ainda, no rol da ANS* -, a ré não estaria obrigada a prestar-lhe cobertura, pois, do contrário, inútil seria o contrato e toda a regulamentação, as cláusulas contratuais e riscos previamente assumidos no contrato.

Pois bem, no que atine à negativa de cobertura pelo plano, tenho que as resoluções da ANS não podem, e nem devem, sobrepujar texto de lei, principalmente no que se refere a restringir direito fundamental, sob pena de recaírem em inexorável ilegalidade, especialmente ao incluírem cláusulas restritivas no plano aderido.

Neste ínterim, tenho que a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispensa as operadoras do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12, que se referem à cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares e ambulatoriais anteriormente citados.

Desta maneira, tem-se que, pela interpretação do art. 10, VI, da Lei nº 9.656 /1998 e art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021 (*todos estes citados em contestação*), é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo as hipóteses legais já pontuadas.

Neste sentido, vale o registro de que "domiciliar", de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital.

Em outras palavras, essa é a razão pela qual os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.

Mesmo assim, possível seria, sob via de exceção, conceder o medicamento desconsiderando a taxatividade do rol da ANS, conforme entendimento do STJ no REsp 1.886.929, nos casos em que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovas também para seus nacionais.

Em sintonia com o referido REsp, foi publicada a Lei nº 14.454/2022 que adicionou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, reafirmam o caráter exemplificativo do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Vejamos:

> Art. 10. (...)
>
> § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)
>
> § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

> I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)
>
> II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Assim, admite-se a desconsideração da taxatividade do ROL em situações específicas, a exemplo de inexistir substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS.

Voltando para o caso concreto, vejo que para que houvesse a cobertura do medicamento em questão, imprescindível seria demonstrar o preenchimento dos requisitos enumerados acima no artigo de lei citado.

Contudo, observo pelos documentos trazidos pela parte autora que nem mesmo um laudo médico contendo uma explanação acerca da enfermidade que lhe acomete, e da premente necessidade do uso do medicamento, fora juntado aos autos, ônus que lhe competia.

A parte autora apenas anexou um receituário (id. 167842789), indicando o uso do medicamento, além de laudos de exames, que sozinhos não servem como meio de prova.

Assim, penso que a parte autora não demonstrou preencher nenhum dos requisitos exigidos pela alteração da lei, de modo que o seu pedido não deve prevalecer.

Os tribunais do país também têm entendimento similar, quando do julgamento de causas em que o plano de saúde exclui da cobertura as medicações de uso domiciliar, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE imPROCEDÊNCIA do pedido inicial. 1. **MÉRITO. AUTORA DIAGNOSTICADA COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CID 10 J84.1). PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE 150mg - OFEV, PARA CONTER O AVANÇO DA PATOLOGIA**. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO FÁRMACO, COM POSTERIOR REVOGAÇÃO EM SENTENÇA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. FÁRMACO QUE, EMBORA CADASTRADO NA ANVISA COMO ANTINEOPLÁSICO, NÃO É UTILIZADO PARA O TRATAMENTO DE NEOPLASIA NO CASO CONCRETO. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA (ART. 10, INC. VI, C/C ART. 12, INC. II, ALÍNEA G, DA LEI Nº 9.656/98). **EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO. CLÁUSULA RESTRITIVA REDIGIDA EM DESTAQUE E DE FÁCIL COMPREENSÃO PELA CONSUMIDORA. NEGATIVA LEGÍTIMA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.** 2. PEDIDO AUTORAL DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE POSSUI MONTANTE ECONÔMICO APURÁVEL. MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. UTILIZAÇÃO DO CUSTO MÉDIO ANUAL DO TRATAMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANTIDO O VALOR DA CAUSA, TAL COMO RETIFICADO PELO JUÍZO EM SENTENÇA. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, § 11º, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - 0004141-93.2020.8.16.0146 - Rio Negro - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 07.02.2022)

(TJ-PR - APL: 00041419320208160146 Rio Negro 0004141-93.2020.8.16.0146 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 07/02/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2022)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. **PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. ANTICOAGULANTE. AUTOADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE.** AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "**É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim**. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, **o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito - anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde**. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

STJ - AgInt no REsp: 1859473 RJ 2020/0019511-3, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) – grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ENOXAPARINA E LIPOFUNDIN - TRATAMENTO DE TROMBOFILIA E POLIMORFISMO DO GENE PAI-1 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - **FÁRMACO DE USO DOMICILIAR - EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO** - RECURSO PROVIDO - **Nos contratos regulamentados, o fornecimento de medicamentos e insumos de uso domiciliar, na modalidade assistência domiciliar, somente é obrigatório pela operadora de saúde se houver expressa previsão contratual, ou quando, embora não haja previsão contratual, o uso do fármaco e de outro tratamento no ambiente domiciliar se dê em substituição ao ambiente hospitalar, o que não é o caso - Estando ou não a tecnologia postulada no rol da ANS, como o tratamento se refere a um medicamento de uso domiciliar e não está dentre as exceções que devem ser cobertas pelo plano de saúde, não se vislumbra a obrigatoriedade de fornecimento do aludido fármaco pela operadora de saúde** - Inexistindo nos autos elementos que demonstrem a presença da plausibilidade das alegações da parte autora, afigura-se de rigor o indeferimento da tutela de urgência - Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - AI: 08795610320238130000, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 29/06/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2023) – grifei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR - NÃO OBRIGATORIEDADE - EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA - LICITUDE - **É lícita a**

exclusão contratual do fornecimento de medicamento para uso domiciliar, devendo ser obedecido o princípio do "pacta sunt servanda" - O art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, exclui expressamente o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto os medicamentos para cobertura de tratamentos antineoplásicos previstos no art. 12, da mesma lei.

(TJ-MG - AC: 10000221059744001 MG, Relator: Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2022) – grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE NEOPLASIA OU DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. HIPÓTESES TAXATIVAS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ANS, por meio da Resolução Normativa nº 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp nº 1886929 e EREsp nº 1889704. 3. Exceto doença maligna e esclerose múltipla, não há (e já não havia) amparo legal para fornecimento de medicação de uso domiciliar. **Plano de saúde não compreende assistência farmacológica domiciliar, salvo essas duas exceções previstas pela ANS. 4. Inviável manter a obrigação do plano de saúde em fornecer medicamento não contratado pela cobertura da operadora enquanto não integrar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar; não**

> **houver contratação de cobertura ampliada ou negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimentos extra Rol**. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07106728820228070000 1434408, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 21/06/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2022)

Nesta senda, entendo que se a parte autora contratou – *e pagou* – por seguro cuja cobertura não abarque medicação para uso domiciliar, não poderia a ré ser compelida a prestar garantia maior do que a efetivamente paga pelo segurado.

Isso porque, como visto, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º da Lei n. 8.080 /1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos.

Neste contexto, é importante destacar que não se discute, no presente caso, a indicação do medicamento ou o tratamento proposto à autora, mas sim a ausência de obrigação, seja contratual ou legal, de cobertura do referido fármaco por parte da ré.

Desta forma, por tudo o que foi posto, sendo o medicamento de uso domiciliar, uma vez que é administrado na forma de comprimidos pela autora, existindo cláusula contratual específica excluindo da cobertura esse tipo de medicação, e, ainda, constatada que essa exclusão não é ilegal, tenho que a pretensão da autora não merece guarida.

Por fim, quanto ao pedido de danos morais, não existindo abusividade na recusa do fornecimento da medicação, resta afastada a sua configuração, posto inexistir ofensa a direito extrapatrimonial do requerente passível de indenização.

Diante do exposto e em consonância com os fundamentos retratados, RESOLVO O MÉRITO, com esteio do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Nesta oportunidade CASSO, tornando sem efeito pois, a Tutela de Urgência deferida quando da decisão de ID 168115456.

Custas e honorários advocatícios, pelo demandante, sendo que estes, nos termos do art. 85, §3º, I, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor, atualizado, da causa, ressalvando-se, porém, a suspensão da exigibilidade, por litigar o autor sob o pálio da justiça gratuita, conforme art. 98, §§1º, 2º e 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

No caso de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada, por intermédio de seus advogados/procuradores para, no prazo de 15 (quinze) dias (a teor do art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil), apresentar, querendo, contrarrazões.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação da resposta, remetam-se os autos à instância superior, com as nossas homenagens, e após as baixas necessárias na Distribuição, independentemente de novo comando judicial.

Após cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as baixas necessárias e as cautelas de estilo.

Recife-PE, data e assinatura eletrônicas.

MARCO AURÉLIO MENDONÇA DE ARAÚJO – Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCO AURELIO MENDONCA DE ARAUJO
08/10/2024 08:01:04
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 184534911

24100808010398200000180001685

IMPRIMIR GERAR PDF